

Criterios diagnósticos de abuso y dependencia

1. Introducción y relevancia clínica

El diagnóstico correcto de un **trastorno por uso de sustancias (TUS)** permite diferenciar entre un **consumo ocasional o recreativo**, un **uso problemático** y una **dependencia clínica** que requiere intervención especializada.

En Chile, este enfoque se enmarca en las **Guías Clínicas MINSAL 2022** y en los programas del **Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)**.

El diagnóstico se basa en criterios clínicos, no en juicios morales ni en el tipo de sustancia: **lo relevante es la pérdida de control y el impacto funcional**.

- En el **EUNACOM**, suelen aparecer casos de pacientes con consumo crónico (alcohol, cocaína, cannabis, benzodiacepinas, etc.) donde se pide establecer si cumple criterios de dependencia o abuso según **DSM-5 o CIE-10**, y decidir el siguiente paso clínico (educación, derivación, farmacoterapia o internación).
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Conceptos clave

- **Uso:** consumo voluntario de una sustancia con fines recreativos o terapéuticos.
 - **Uso problemático:** consumo que genera consecuencias adversas físicas, psicológicas o sociales, sin cumplir todos los criterios de dependencia.
 - **Dependencia:** patrón de consumo compulsivo, con pérdida de control y síntomas de abstinencia al suspender.
-

2.2. Neurobiología de la dependencia

El eje central de la adicción es el **sistema de recompensa dopaminérgico**, especialmente el **núcleo accumbens**, **área tegmental ventral (VTA)** y **corteza prefrontal**.

Las sustancias adictivas actúan sobre este circuito, generando refuerzo positivo (placer) y posteriormente **refuerzo negativo** (consumo para evitar el malestar de la abstinencia).

- **Etapla inicial:** búsqueda de placer (dopamina ↑).
 - **Etapla crónica:** búsqueda de alivio del disconfort (GABA y glutamato disfuncionales).
 - Se desarrollan **tolerancia, craving** y alteraciones en el **control inhibitorio frontal**.
-

2.3. Transición del uso al trastorno

1. **Uso experimental** → consumo social, esporádico.
2. **Uso habitual** → patrón repetido para aliviar estrés o malestar.
3. **Abuso** → consecuencias negativas evidentes, pero el consumo continúa.
4. **Dependencia** → pérdida de control, compulsión, abstinencia, deterioro funcional.

Este proceso puede variar en duración y depende de **factores genéticos, psicológicos y sociales**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El cuadro clínico de un **trastorno por consumo de sustancias** combina manifestaciones físicas, emocionales y conductuales:

3.1. Manifestaciones comunes

- **Pérdida de control:** consumo mayor o más prolongado del planificado.
- **Craving o urgencia irresistible.**
- **Negligencia de obligaciones laborales, académicas o familiares.**
- **Uso continuado pese a daño físico o psicológico evidente.**
- **Cambios conductuales:** irritabilidad, aislamiento, problemas legales o económicos.

3.2. Manifestaciones físicas

- Signos de intoxicación (según sustancia).

- Síntomas de abstinencia.
- Alteraciones en peso, sueño y apetito.
- Deterioro del autocuidado.

3.3. Diagnóstico diferencial

- **Trastornos afectivos o de ansiedad** (pueden coexistir).
 - **Uso terapéutico prolongado** (p. ej., opioides o benzodiacepinas indicadas).
 - **Trastornos de personalidad** (impulsividad, antisocial).
 - **Simulación o consumo puntual no compulsivo.**
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Herramientas diagnósticas en Chile (MINSAL, SENDA)

1. **Entrevista clínica estructurada:** eje central del diagnóstico.
 2. **AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)** → cribado de abuso de alcohol.
 3. **DAST (Drug Abuse Screening Test)** → para otras drogas.
 4. **ASSIST (OMS)** → evalúa múltiples sustancias y nivel de riesgo.
 5. **Test de orina o saliva** → corroborar consumo reciente.
-

4.2. Criterios DSM-5 para Trastorno por Uso de Sustancias

Un mismo esquema aplica a todas las drogas (alcohol, cannabis, opioides, etc.).

Se diagnostica si se cumplen **≥2 de los siguientes 11 criterios** en un periodo de **12 meses**:

A. Pérdida de control

1. Consumo en cantidades mayores o durante más tiempo del previsto.
2. Deseo persistente o esfuerzos fallidos por reducir o controlar el consumo.
3. Gran parte del tiempo se dedica a conseguir, usar o recuperarse del efecto.
4. Craving o deseo intenso de consumir.

B. Consecuencias sociales

5. Incumplimiento de obligaciones en trabajo, escuela o familia.
6. Consumo continuado pese a problemas interpersonales o sociales.
7. Abandono o reducción de actividades importantes.

C. Riesgo y daño físico

8. Consumo en situaciones físicamente peligrosas.
9. Persistencia a pesar de problemas médicos o psicológicos derivados.

D. Adaptaciones fisiológicas

10. **Tolerancia:** necesidad de dosis crecientes o efecto disminuido.
11. **Abstinencia:** síndrome específico o consumo para aliviarla.

Gravedad:

- **Leve:** 2–3 criterios.
- **Moderado:** 4–5 criterios.
- **Grave:** ≥ 6 criterios.

□ Ejemplo clínico típico EUNACOM:

Paciente que consume cocaína los fines de semana, ha intentado dejarla sin éxito, falta al trabajo y presenta craving → cumple ≥ 4 criterios → **trastorno moderado**.

4.3. CIE-10 (OMS) — Dependencia

Para diagnóstico de **síndrome de dependencia**, se requieren **≥3 criterios** presentes en el último año:

1. Deseo intenso o compulsión de consumir.
2. Dificultad para controlar el inicio, cantidad o final del consumo.
3. Síntomas de abstinencia o consumo para evitarlos.
4. Tolerancia.
5. Desinterés progresivo en actividades no relacionadas con la droga.
6. Persistencia a pesar de daños evidentes.

□ A diferencia del DSM-5, la CIE-10 separa “uso nocivo” (abuso) y “dependencia”. La **CIE-11**, ya adoptada por Chile, unifica ambos en “Trastorno por consumo de sustancias”.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / Chile)

5.1. Enfoque integral

El tratamiento depende de la gravedad y tipo de sustancia, pero **siempre** debe integrar tres componentes:

Dimensión	Intervención
Biológica	Desintoxicación y farmacoterapia específica.
Psicológica	Terapia cognitivo-conductual, entrevista motivacional.
Social	Rehabilitación, reinserción laboral, apoyo familiar y comunitario.

5.2. Estrategias según severidad

Leve (uso riesgoso o nocivo)

- Intervención breve motivacional en APS (5–15 min).
- Educación sobre efectos y reducción de daño.
- Reforzar red de apoyo.

Moderado

- Psicoterapia ambulatoria intensiva (TCC, terapia grupal).
- Derivación a **COSAM** o **centro especializado SENDA**.

Grave o con comorbilidad psiquiátrica

- Desintoxicación supervisada.
- Tratamiento farmacológico según sustancia (p. ej., metadona, naltrexona, disulfiram).
- Internación en programas residenciales.

5.3. Intervención motivacional

Basada en el modelo de **Prochaska y DiClemente**:

Etapas	Estrategia del profesional
Precontemplación	Generar conciencia sin confrontar.
Contemplación	Explorar ambivalencias y beneficios del cambio.
Preparación	Planificar metas concretas.
Acción	Apoyo conductual activo y seguimiento.

Mantenimiento Refuerzo positivo y prevención de recaídas.

☐ La entrevista motivacional es esencial para pasar del consumo negado a la acción terapéutica.

5.4. Psicoeducación familiar

- Explicar la adicción como **enfermedad crónica, no falta de voluntad**.
- Entrenar en reconocimiento de señales de recaída.
- Promover límites claros y apoyo emocional sin sobreprotección.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones médicas y sociales

- Hepatopatía alcohólica, VIH, hepatitis B/C, cardiopatías.
- Accidentes, violencia doméstica, conflictos legales.
- Comorbilidad psiquiátrica: depresión, ansiedad, psicosis inducida.
- Suicidio (hasta 20% de las muertes en dependientes graves).

6.2. Pronóstico

Depende de múltiples factores:

Factor	Impacto
Alta motivación	Mejora significativamente la abstinencia.

Apoyo familiar y social

Disminuye recaídas.

Trastorno dual no tratado

Peor evolución.

Participación en programas
prolongados

Mejor reinserción.

El tratamiento exitoso suele requerir **≥6 meses de seguimiento activo**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **El diagnóstico se basa en conductas, no en la cantidad consumida.**
 2. **Craving** es un criterio diagnóstico clave introducido en DSM-5.
 3. **Uso nocivo (CIE-10)** no implica dependencia, pero sí daño físico o psíquico.
 4. El tratamiento efectivo combina **motivación + psicoterapia + farmacoterapia**.
 5. **Entrevista motivacional** es la herramienta de primera línea en APS.
 6. La **CIE-11** unifica “abuso” y “dependencia” en una sola categoría.
 7. Evaluar siempre **comorbilidad psiquiátrica** (ansiedad, depresión, TDAH).
-



Errores comunes

- Basar el diagnóstico solo en la frecuencia del consumo.
- Etiquetar moralmente (“es débil”, “no quiere cambiar”).

- Ignorar craving o tolerancia en ausencia de abstinencia visible.
 - Tratar la intoxicación aguda sin plan de seguimiento.
 - No ofrecer intervención breve en APS.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **trastorno por consumo de sustancias** se diagnostica clínicamente según **criterios DSM-5 o CIE-10**.
2. Los criterios más relevantes son **pérdida de control, craving, tolerancia, abstinencia y daño funcional**.
3. La **CIE-11** (implementación MINSAL) unifica “uso nocivo” y “dependencia”.
4. El **diagnóstico temprano en APS** y la **entrevista motivacional** son fundamentales para prevenir dependencia.
5. El tratamiento exitoso combina **intervención psicológica, farmacológica y apoyo social**.
6. Evaluar siempre **comorbilidad psiquiátrica y riesgo suicida**.
7. La **rehabilitación y seguimiento prolongado** son esenciales para mantener la abstinencia.